

Механизмы нарушения регуляции эмоций при биполярном расстройстве

08.06.2026 / [Новости](#)





Биполярное расстройство — это распространённое и тяжёлое заболевание, характеризующееся рецидивирующими аффективными эпизодами и субсиндромальной аффективной симптоматикой. Современные рекомендации по лечению биполярного расстройства в основном ориентированы на эпизодическую модель течения, акцентируя внимание на купировании и профилактике острых фаз. Однако у многих пациентов настроение остаётся нестабильным даже в периоды ремиссии.

Нарушение регуляции эмоций представляет собой многомерную конструкцию, включающую широкий спектр психических расстройств. Данный термин часто используется как синоним эмоциональной нестабильности, аффективной лабильности, аффективной неустойчивости и перепадов настроения.

Несмотря на отсутствие единого определения, нарушение регуляции эмоций можно охарактеризовать как такие особенности эмоционального опыта и его выражения, которые препятствуют целенаправленной деятельности.

Стратегии регуляции эмоций принято делить на адаптивные и дезадаптивные, в зависимости от их эффективности и влияния на аффективное состояние. Трудности в управлении отрицательными эмоциями, а также использование дезадаптивных стратегий совладания (например, катастрофизация, самоуничтожение, руминация) ассоциированы с более высоким уровнем психопатологии.

Нарушение регуляции эмоций при биполярном расстройстве

У пациентов с биполярным расстройством нарушения регуляции эмоций могут наблюдаться вне зависимости от фазы расстройства. Такие нарушения способствуют эмоциональной полярности и аффективной нестабильности, что, в свою очередь, может провоцировать развитие маниакальных и депрессивных эпизодов.





поведения, что является эмоционально обусловленной импульсивностью. Высокий уровень эмоционально обусловленной импульсивности ассоциирован с более выраженной суицидальностью и агрессивным поведением.

Многие из характеристик эмоциональности выявляются еще до манифеста расстройства. Нарушение регуляции эмоций рассматривается как возможный эндотип биполярного расстройства: её проявления фиксируются как в острых эпизодах, так и в ремиссии, а также у здоровых родственников пациентов. Систематические обзоры подтверждают, что нарушения регуляции эмоций присутствуют и у родственников пациентов с биполярным расстройством.

Биологическая основа нарушений регуляции эмоций при биполярном расстройстве

Биполярное расстройство — это расстройство с многофакторной этиологией. Современные исследования подчёркивают значение генетических и эпигенетических механизмов, факторов внешней среды и продромальных проявлений, предшествующих гипо/мании или депрессии. Показано, что при биполярном расстройстве происходят нарушения в различных биологических системах, включая изменение структуры и функциональной связности мозга, окислительный стресс, митохондриальную дисфункцию, воспаление, дестабилизацию циркадианных ритмов, нарушение дофаминергической передачи, аномалии нейротрофической системы, а также сбои в кальциевой сигнализации.

Эти же биомеханизмы могут лежать в основе нарушения регуляции эмоций. Установлено, что ключевые области мозга, участвующие в регуляции эмоций — префронтальная кора и лимбическая система — демонстрируют изменённые паттерны активации у пациентов с биполярным расстройством. Эти особенности коррелируют с нарушениями так называемой “аффективной” когниции, которая включает эмоциональную обработку, восприятие, избирательное внимание, эмоциональное принятие решений, а также регуляцию положительного и отрицательного подкрепления.





выраженная гиперактивация миндалины и гиппокампа, при биполярном расстройстве — гипоактивация вентролатеральной префронтальной коры, а при униполярной депрессии — гиперактивация миндалины.

Биполярное расстройство и расстройство дефицита внимания и гиперактивации (РДВГ) имеют обширное клиническое и патофизиологическое перекрытие. Оба расстройства часто коморбидны, характеризуются импульсивностью, психомоторной ажитацией, нарушением сна и когнитивными дефицитами. Нейроанатомически у пациентов с РДВГ выявлено снижение объема серого вещества в правой островковой и передней поясной коре, как и при биполярном расстройстве. Однако есть и различия: при РДВГ отмечено снижение активации в вентромедиальной префронтальной коре по сравнению со здоровыми и пациентами с биполярным расстройством.

Литий остаётся “золотым стандартом” фармакотерапии биполярного расстройства, однако механизмы его терапевтического действия до конца не ясны. Нейровизуализационные исследования показали, что приём лития приводит к нормализации или увеличению объема серого вещества в передней поясной коре, миндалине и гиппокампе — ключевых областях, отвечающих за эмоциональную регуляцию. Также выявлены изменения функциональной связности между префронтальными и лимбическими зонами.

Нейропластичность и нейротрофический фактор мозга BDNF

BDNF — это многофункциональный нейротрофин, играющий важную роль в нейропластичности и поддержании функций ЦНС, а также в модуляции стресс-реакций. Давно установлена роль BDNF в патофизиологии психических расстройств, включая биполярное расстройство. Выявлено, что экспрессия BDNF варьирует в зависимости от фазы расстройства. Например, уровни BDNF снижаются в маниакальной и депрессивной фазах по сравнению с контролем и униполярной депрессией. В контексте регуляции эмоций при биполярном расстройстве BDNF может служить объективным маркером эффективности интервенций, направленных на ее улучшение.





У многих пациентов с биполярным расстройством циркадианные ритмы нарушены даже в состоянии ремиссии. Супрахиазматическое ядро, расположенное в переднем гипоталамусе, синхронизирует циклы сна-бодрствования, терморегуляцию и секрецию нейромедиаторов и гормонов. Нарушения в работе ядра или его синхронизации с внешними сигналами могут приводить к десинхронизации биоритмов.

Изменения фаз, структуры и длительности сна наблюдаются во всех фазах биполярного расстройства. Хроническое нарушение сна снижает когнитивную функцию и нарушает контроль исполнительных функций, влияя на регуляцию эмоций. При бессоннице отмечаются нарушения нейронных контуров регуляции эмоций, а также снижение базовых и высших когнитивных функций. Бессонница ассоциирована с эмоциональной гиперреактивностью даже в ремиссии. Симптомы бессонницы у пациентов с биполярным расстройством предсказывают выраженность депрессии, нарушение регуляции эмоций и суицидальности.

Утренний или вечерний хронотип отражает индивидуальные предпочтения в активности в течение суток. Вечерний хронотип независимо связан с нарушением регуляции эмоций, вне зависимости от качества и продолжительности сна. Утренние хронотипы демонстрируют меньше эмоциональных и когнитивных трудностей. У лиц с вечерним хронотипом отмечается усиленная реакция миндалины на негативные стимулы и сниженная функциональная связность миндалины – дорсальная передняя поясная кора, что указывает на нарушенные контуры регуляции эмоций.

У пациентов с биполярным расстройством вечерний хронотип встречается чаще. Хронотип обладает наследуемостью и рассматривается как потенциальный биомаркер ответа на литий. Литий может стабилизировать настроение, воздействуя на циркадианную систему — он увеличивает амплитуду ритмов и замедляет их период. Этот эффект достигается, в частности, за счёт ингибирования гликогенсинтазы-киназы-3 β , которая регулирует циркадианный рецептор, влияющий на дофаминергическую систему. Таким образом, модуляция циркадианных механизмов может рассматриваться как перспективное направление коррекции нарушения регуляции эмоций при биполярном расстройстве.

Читать материал полностью на портале
Гедеон Рихтер





PMCID: PMC12098583.

« Previous Post: Что на самом деле
сказал Курт Шнайдер и что DSM
сделала из этого

Next Post: Почему бред становится
фиксированным »

О Пин

